Protocolo de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y adolescencia desde Atención Primaria
PARTE II

JOSEFINA HERNÁNDEZ RUIZ

R3 MFYC

INDICE

- Definición de Maltrato Infantil.
- Tipos de Maltrato Infantil.
- Factores de riesgo y de protección.
- Situación epidemiológica.
- Detección o sospecha de la situación de violencia.
- Valoración inicial de la violencia.
- Notificación.
- Recursos.
- Bibliografía.

Región de Murcia
Consejería de Política Social, Familias e Igualdad

PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL MALTRATO INFANTIL EN LA REGIÓN DE MURCIA

Procedimiento de actuación ante posibles casos de maltrato infantil

ÁMBITO SANITARIO -AP

5. Detección o sospecha de la situación de violencia

Puede generarse ante:

- La **comunicación explícita** por parte del menor o cualquier persona de su entorno, así como por la **comunicación no verbal** (gestualidad, la expresión facial o la postura corporal).
- La **comunicación por profesionales de otros ámbitos** (educación, servicios sociales, Centros de Atención Temprana, programas deportivos, ocio y tiempo libre, agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales que intervienen en las situaciones de violencia de género, etc.).
- La detección de **indicadores de sospecha*** identificados durante la atención.

5.1. Indicadores de negligencia

Indicadores físicos en los NNA	▪ Higiene deficiente. Ropa inadecuada para las condiciones climáticas. ▪ Retraso del crecimiento. Desnutrición por falta de aportes adecuados a la edad y las necesidades, una vez descartadas otras causas. ▪ Accidentes reiterados por falta de supervisión. ▪ Falta de vacunaciones y de cuidados médicos. ▪ Retraso en cualquiera de las áreas del desarrollo por falta de estimulación. ▪ Alimentación y/o hábitos horarios inadecuados. ▪ Heridas, lesiones o marcas. Síntomas de enfermedades ocasionadas por el maltrato.
Indicadores comportamentales en NNA	▪ Somnolencia, apatía, depresión, agresividad, tristeza, comportamiento antisocial. ▪ Conductas y expresiones impropias de su edad. ▪ Participa en actividades delictivas. ▪ Fracaso y/o absentismo escolar, retraso en el lenguaje. ▪ Dice que no hay quien le cuide. ▪ Inmadurez emocional; retraso madurativo global.
Indicadores de la persona sospechosa de ejercer la violencia[10]	▪ No escolarizar al NNA a su cargo en relación a su edad. ▪ Consumo de tóxicos durante la gestación y/o posteriormente. ▪ Falta de supervisión parental. ▪ Toleran todos los comportamientos del niño/a sin ponerle ningún límite. ▪ Padres y madres ausentes en su función parental. ▪ Consultas frecuentes a los servicios de urgencia por falta de seguimiento médico. ▪ Enfermedad crónica llamativa que no genera consulta médica. ▪ Ausencia de cuidados médicos rutinarios. ▪ Falta o inadecuación de cuidados y atención de las necesidades especiales por padecer enfermedad crónica. ▪ Separaciones conflictivas de padres y madres (utilización de los hijos/as en denuncias y acusaciones).

5.2. Indicadores de maltrato emocional o psicológico

Indicadores comportamentales en el NNA	▪ Desconfianza y apatía hacia la persona adulta. ▪ Busca contactos físicos inapropiados. ▪ Inhibición en el juego con otros NNA. ▪ Inmadurez socioemocional. ▪ Baja autoestima, ánimo deprimido. ▪ Carácter asustadizo, tímido, pasivo. ▪ Disminución de la capacidad de atención. ▪ Retraso en el lenguaje y/o fracaso escolar. ▪ Trastornos de la conducta alimentaria, del sueño, o del control de esfínteres (enuresis, encopresis). ▪ Trastornos relacionados con estructuras del pensamiento obsesivo, fobias, ansiedad, regresión, impulsividad, falta de control de sus conductas y falta de empatía y de mentalización propia y de las emociones de las otras personas. ▪ Conductas de autolesión, ideación o intentos de suicidio. ▪ Comportamientos antisociales, participa en actividades delictivas y/o practica conductas de riesgo para la salud (uso y/o abuso de tabaco, otras drogas, alcohol); actividad sexual temprana y sin medidas anticonceptivas, promiscuidad sexual, prostitución.

Indicadores de la persona sospechosa de ejercer la violencia[11]	▪ Exhibe frialdad y falta de afecto en el trato del /hacia el NNA. ▪ Rechazo verbal, insultos al NNA. Disciplina desproporcionada. ▪ Obliga a practicar convicciones y creencias extremas (nutricionales, religiosas, culturales). ▪ Niega atención médica, tratamientos o medidas preventivas en función de sus propias creencias. ▪ Parece no preocuparse por los problemas del NNA. ▪ Tolera todos los comportamientos sin poner límite alguno. ▪ No acepta la iniciativa del NNA; impide una mayor autonomía. ▪ Aparta al menor de las interacciones sociales. ▪ Tiene un exceso de vida social o laboral, persona responsable ausente. ▪ Alienta a cometer conductas delictivas; expone al menor a pornografía; premia conductas agresivas. ▪ Violencia de género.

5.3. Indicadores de maltrato físico

Indicadores físicos en el NNA	▪ Las erosiones, equimosis o hematomas son las lesiones más frecuentes de maltrato físico seguidas de las fracturas. Debemos sospechar de los hematomas o magulladuras cuando: - Son múltiples o hay presencia frecuente y reiterada de lesiones (importante en <3 años). - Se encuentran en diferentes estadios evolutivos. - Se localizan en zonas poco habituales o protegidas por la ropa (por ej. en nalgas, cara interna de muslos, espalda, tronco, genitales y orejas). - Tienen formas geométricas o formas que delatan el objeto con el que se hizo. - Hay equimosis en antebrazos o crestas iliacas como mecanismo de sujeción. - Se encuentran en el cuero cabelludo asociados a lesiones intracraneales. - Siempre que aparezcan en niños y niñas menores de 4 meses de edad. - Lesiones centinela: o 0-6 meses: rasguños, quemaduras, lesiones orofaríngeas (rotura del frenillo, tanto labial como lingual). o 6-12 meses: fracturas de huesos largos o craneales, hemorragias intracraneales. o Menores de 24 meses: fractura de costillas, traumatismos abdominales, hemorragias subconjuntivales y lesiones genitales. - El acrónimo TEN- 4 FACES en menores de 4 años nos ayuda a recordar las localizaciones de hematomas más sugestivas de causa no accidental (ver ilustración 3). ▪ Mordedura humana: la huella de una persona adulta tiene una separación mayor de 3 centímetros entre caninos. ▪ Alopecia traumática por arrancamiento intencional localizada en la zona occipital o parietooccipital en diferentes estadios de evolución. ▪ Quemaduras: ▪ Fracturas. o Cualquier fractura en un niño o niña que no camina. o Fracturas múltiples o en distintos estadios de curación. o Fractura metafisaria en niño/a menor de 1 año. o Fractura diafisaria en espiral u oblicua de los huesos largos, sobre todo en menores de 3 años. o Fracturas posteromediales de costillas en lactantes. o Fracturas craneales: sobre todo si son bilaterales, complejas y de trayecto anfractuoso, deprimidas o que atraviesan suturas. Si la energía del impacto es muy elevada, se asocian a hematomas subdurales.

5.3. Indicadores de maltrato físico

Indicadores comportamentales en NNA	▪ Muestra cautela con respecto al contacto físico con personas adultas. ▪ Parece tener miedo de su padre, madre o personas cuidadoras, de ir a casa, o llora cuando terminan las clases y tiene que irse de la escuela o escuela infantil. ▪ Dice que la persona responsable de su cuidado o compañeros/as le han causado daño alguna vez. ▪ Va excesivamente vestido y se niega a desnudarse ante otros. ▪ Siente inquietud desmedida por el llanto de otros niños/as. ▪ Muestra conductas extremas (ej. agresividad o rechazo extremos). ▪ Tendencia a la soledad y aislamiento.
Indicadores de la persona sospechosa de ejercer la violencia[12]	▪ Ha sido objeto de maltrato en su infancia. ▪ Utiliza una disciplina severa, inapropiada para la edad, la falta cometida y condición de la persona menor de edad. ▪ No da ninguna explicación con respecto a la lesión del niño/a o estas son ilógicas, no convincentes o contradictorias. ▪ Parece no preocuparse por el NNA. ▪ Percibe al niño/a de manera significativamente negativa, por ejemplo, le ve como malo, perverso, un monstruo, etc. ▪ Abuso de alcohol u otras drogas. ▪ Intenta ocultar la lesión o proteger la identidad de la persona responsable de ésta.

TEN-4-FACESp

REGLA DE DECISIÓN CLÍNICA SOBRE HEMATOMAS PARA NIÑOS MENORES DE 4 AÑOS DE EDAD

¿Cuándo son los hematomas, en niños o niñas menores de 4 años, sugestivos de violencia?

Si hay hematomas en cualquiera de los tres componentes (regiones, niños o niñas de 4 meses o menos, patrones) sin una explicación razonable, se ha de considerar seriamente evaluar la presencia de violencia y/o consultar con una persona experta en violencia infantil.

TEN

Torso Torso

Ears Orejas

Neck Cuello

FACES

Frenulum- Frenillo

Angle of Jaw- Ángulo de la Mandíbula

Cheeks (fleshy part) – Mejillas (parte carnosa)

Eyelids- Párpados

Subconjunctivae- Subconjuntiva

REGIONES

4 meses o menos

Cualquier hematoma en cualquier localización

BEBÉS

Hematomas con patrón

Hematomas con patrones específicos como bofetada, agarre o marcas de bucles

PATRONES

Percibe las señales

Los hematomas sin explicación razonable en estas áreas con frecuencia se deben a violencia física.

TEN-4-FACESp no pretende diagnosticar casos de violencia, sino servir como herramienta de detección para mejorar el reconocimiento de niños o niñas con hematomas potencialmente víctimas de violencia que requieren una evaluación adicional.

TEN-4- FACESp fue desarrollado y validado por la Dra. Mary Clyde Pierce y colegas. Disponible en: **https://research.luriechildrens.org/en/community-population-health-and-outcomes/smith-child-health-outcomes-research-and-evaluation-center/tricam/ten-4-facesp/**

Se ha obtenido permiso de la Dra. Mary Clyde Pierce para la traducción al español y difusión de esta regla de decisión clínica.

5.4. Indicadores de violencia sexual

- Lesiones en zonas genital y/o anal.
- Infecciones genitales y/o enfermedades de transmisión sexual.
- Molestias o lesiones en la zona anal/genital.
- Fuerte resistencia a la exploración de genitales.
- Dice haber sido objeto de conductas compatibles con cualquier forma de violencia sexual.
- Manifiesta conductas o conocimientos sexuales extraños, sofisticados, inusuales o impropias de la edad.
- Conocimiento sexual precoz e inapropiado para su edad.
- Conductas sexualizadas o agresiones sexuales a otros NNA.
- Trastornos del sueño y alimentación.
- Síndrome de estrés postraumático.
- Sintomatología psicosomática. Enuresis, encopresis.
- Baja autoestima. Terrores nocturnos.
- Cambios repentinos de conducta.

6. Valoración inicial de la violencia

PUNTOS CLAVE – Entrevista al menor de edad
1. Explicar la confidencialidad, cuándo y con quién vamos a compartir los datos
2. Mostrar sensibilidad y empatía
3. Escuchar activamente y utilizar preguntas abiertas
4. Descubrir la visión del niño
5. Comprobar que hemos entendido lo que el niño ha dicho
6. Utilizar un lenguaje sencillo y claro
7. Progresar al ritmo del niño
8. Ser sensible a sus creencias religiosas y aspectos culturales
9. Dar la oportunidad de interrumpir la conversación y seguir más tarde
10. Explicar qué va a ocurrir después

PUNTOS CLAVE. Entrevista a los progenitores y cuidadores
1. Escuchar activamente su relato
2. Ser honesto
3. Intentar su colaboración en la búsqueda de soluciones
4. Evitar culpabilizarlos *a priori*
5. Reconocer y compartir sus preocupaciones
6. Hacer entender que somos sensibles a los factores que complican su vida: enfermedades crónicas, trastornos del desarrollo, problemas de salud mental, ser refugiados o tener discapacidades
7. Identificar lo que están haciendo correctamente
8. Ser sensible a sus creencias religiosas y aspectos culturales
9. Trabajar creando una cierta confianza mientras mantenemos nuestra responsabilidad profesional
10. Mantener nuestras preguntas sin deteriorar la relación médico-paciente

ALGORITMO DE ENTREVISTA ANTE POSIBLE CASO DE MALTRATO INFANTIL

POSIBLE CASO DE MALTRATO INFANTIL

ENTREVISTA AL NNA

Entrevistador: el más experto *(acompañado por otro colaborador)*

Lugar: reservado y confortable

Cómo: niño solo *(previo consentimiento)* o acompañado por adulto que no interviene

Tiempo: el necesario

Fases:
1. Informar al niño y crear clima de confianza
2. Evaluar la competencia
3. Obtener una narración libre de lo sucedido

Cierre: recapitular, agradecer y reforzar positivamente

Explicar la exploración subsiguiente

ENTREVISTA A CUIDADORES

Entrevistador: el mismo *(acompañado por otro colaborador que tome notas)*

Lugar: el mismo

Cómo: sin la presencia del niño

Tiempo: el necesario

Fases:
1. Explicar el motivo de la entrevista y aclarar el papel del médico cuyo objetivo es ayudar
2. Intentar aclarar dudas sobre los hechos pidiendo una explicación

Muy importante:
No entrar en confrontación
Controlar los sentimientos negativos

6. Valoración inicial de la violencia

Exploración física y psicológica:

- Inspección sobre la **actitud** del NNA, estado emocional, postura corporal, lenguaje no verbal e interacción. También es importante registrar la **higiene**.
- **Somatometría** (talla, peso y perímetro craneal).
- Indicar la **etapa de desarrollo sexual** según la escala de Tanner.
- Valorar la presencia de **lesiones centinelas**.
- Realizar una exploración por órganos y sistemas.

6. Valoración inicial de la violencia

Valoración del riesgo vital y la gravedad:

- Cuando existe riesgo de muerte.
- Cuando existe grave impacto para la salud del NNA.
- Cuando existe trastorno de salud mental.
- Riesgo de suicidio.

Gravedad según:

- Tipo de daño, según el efecto que tiene sobre la integridad física o psíquica del NNA.
- Localización y gravedad de la lesión o lesiones.
- Nivel de vulnerabilidad del NNA: edad, enfermedad previa, discapacidad, etc.
- Signos de negligencia.
- Posibilidad de recogida de muestras en los casos de violencia sexual reciente.

7. Notificación

¿Quién hace la notificación?

El profesional del ámbito sanitario que atienda al NNA. Se puede notificar desde **AP** o **AH**.

*Debe haber un responsable de Violencia en cada centro.

¿Cuándo notificar?

Cuando tengan conocimiento o indicios de una posible situación de violencia que priva a los menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social.

El equipo del centro sanitario considerará dos modos de hacerlo, ordinario o urgente.

¿Cómo notificar?

A través del envío, por vía telemática, de los siguientes documentos:

- **Documento de notificación** para los Servicios Sociales/Entidad Pública de protección a la infancia.
- **Parte de lesiones** para comunicación con el juzgado.

En caso de urgencia, contactar también vía telefónica.

7. Notificación.
7.1. Procedimiento de actuación ante situaciones **No urgentes**.

La situación detectada se ha producido de una **forma puntual** o los **indicadores** de maltrato **no son graves**.

Hay que **notificar siempre** la situación detectada (registro en la HC).

Desde la Unidad sanitaria correspondiente se notificará la situación a los **Servicios Sociales de Atención Primaria**, por medio de la **HOJA DE NOTIFICACIÓN**, para que valoren e intervengan en el caso.

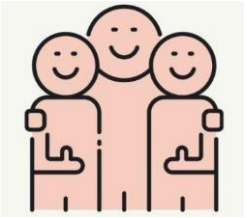
Una vez cumplimentada se realizan los siguientes pasos:

1. **Una copia se envía** por correo postal, electrónico o fax, al **Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria** donde reside el NNA anexando un **informe detallado** de los hechos con el fin de facilitar la valoración/intervención. auroangeles.casanova@ayto-cartagena.es Tlf. 968128910/ 667954490.

   (**Y/o** notificar caso a **Trabajador social** de nuestro Centro de salud)

2. **Otra copia** se envía por correo postal, electrónico (**maltratoinfantil@carm.es**) o fax a la Asesoría de Información y Estudios, para su explotación estadística.

3. Se guardará una **copia para el expediente sanitario en OMI**.



7. Notificación.
7.2. Procedimiento de actuación ante situaciones **Urgentes**.

- **Episodio reciente de violencia sexual:** está indicada la toma de muestras de valor forense **hasta 72 horas** (también en caso de penetración anal), y **hasta 7-10 días** si ha habido penetración vaginal.
- **Existe, ha existido o podría existir riesgo vital (físico, psicológico/emocional):**

- Riesgo de muerte.

- Grave impacto para la salud por la presencia de lesiones o enfermedades.

- Las lesiones o enfermedades requieren tratamiento hospitalario.

- Pueden dejar secuelas físicas o psicológicas.

- Gran afectación psicológica o riesgo de suicidio.

- Está en **riesgo de desprotección** frente a la violencia.

7. Notificación.
7.2. Procedimiento de actuación ante situaciones **Urgentes**.

Se pondrá en conocimiento de los **Servicios Sociales de Atención Especializada** (horario laboral) o **Juzgado de Guardia** (horario no laboral) que autorizará la adopción de una **medida de protección urgente** (acogimiento familiar o residencial).

1. **Atender cualquier necesidad** relacionada con la **salud**, acompañando al NNA a un **centro sanitario** en casos de lesiones físicas, psicológicas, grave negligencia o sospecha de abuso sexual (recabar **parte de lesiones**).

2. En casos que **no sea necesaria la atención médica inmediata** y **no** exista **familiar válido**, se facilitará el **traslado a un centro de protección de menores** con el apoyo de las **FFCCS**.

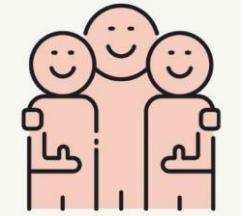
3. Se informará a los **Servicios Sociales de Atención Especializada** enviando por correo electrónico **proteccionytutela@carm.es** una copia de la **Hoja de Notificación** a la **Sección de Protección y Tutela**, perteneciente al Servicio de Protección de Menores + **Informe detallado** de los hechos. **Tlf. 968273162.**

*4. Una **copia** a Servicios Sociales Municipales **(auroangeles.casanova@ayto-cartagena.es**).

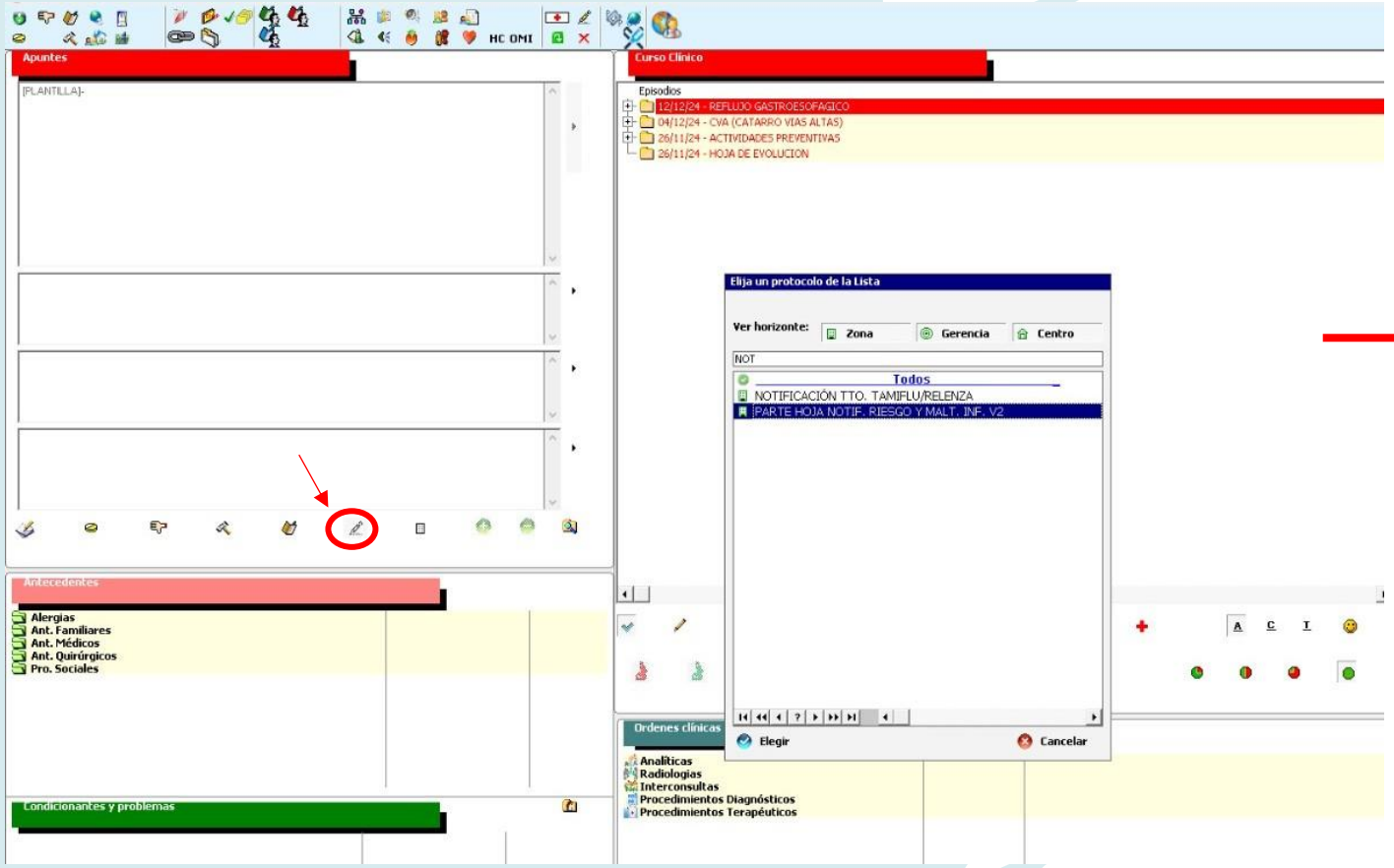
Telf. 968128910 / 667954490.

5. Imprimir la hoja para el **Centro de registro de datos** para su procesamiento estadístico y enviarla al correo de **maltradoinfantil@carm.es**

6. Se guardará una **copia** de la hoja de notificación **para el expediente sanitario en OMI**.



HOJA DE NOTIFICACION EN OMI



Región de Murcia
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración
Dirección General de Familia y Menor

Región de Murcia
Consejería de Sanidad y Consumo

Servicio Murciano de Salud

HOJA DE NOTIFICACIÓN DE RIESGO Y MALTRATO INFANTIL DESDE EL ÁMBITO SANITARIO

L = Leve M = Moderado G = Grave
(Para una explicación detallada de los indicadores, véase el dorso)

Sospecha ☐
Maltrato ☐

MALTRATO FÍSICO

- L M G Magulladuras o moratones 1
- L M G Quemaduras 2
- L M G Fracturas óseas 3
- L M G Heridas 4
- L M G Lesiones viscerales 5
- L M G Mordeduras humanas 6
- L M G Intoxicación forzada 7
- L M G Síndrome del niño zarandeado 8

NEGLIGENCIA

- L M G Escasa higiene 9
- L M G Falta de supervisión 10
- L M G Cansancio o apatía permanente
- L M G Problemas físicos o necesidades médicas 11
- L M G Es explotado, se le hace trabajar en exceso 12
- L M G No va a la escuela
- L M G Ha sido abandonado

MALTRATO EMOCIONAL

- L M G Maltrato emocional 13
- L M G Retraso físico emocional y/o intelectual 14
- L M G Intento de suicidio
- L M G Cuidados excesivos / sobreprotección 15

ABUSO SEXUAL

- SI Sin contacto físico
- SI Con contacto físico y sin penetración 16
- SI Con contacto físico y con penetración
- SI Dificultad para andar y sentarse
- SI Ropa interior rasgada, manchada o ensangrentada
- SI Dolor o picor en la zona genital
- SI Contusiones o sangrado en los genitales externos zona vaginal o anal
- SI Cervix o vulva hinchados o rojos
- SI Explotación sexual
- SI Semen en la boca, genitales o ropa
- SI Enfermedad venérea 17
- SI Apertura anal patológica 18
- SI Himen perforado

Señale la localización de los síntomas

OTROS SÍNTOMAS O COMENTARIOS:

IDENTIFICACIÓN DEL CASO

Identificación del Niño Caso fatal (fallecimiento) SI

Apellidos ____ Nombre ____

Domicilio ____ Localidad ____ Teléfono ____

Sexo V M Fecha de nacimiento (día/mes/año) ____

Acompañante: Padre ☐ Madre ☐ Tutor ☐ Policía ☐ Vecino ☐ Otro (especificar) ____

Identificación del notificador Fecha de notificación (día/mes/año) ____

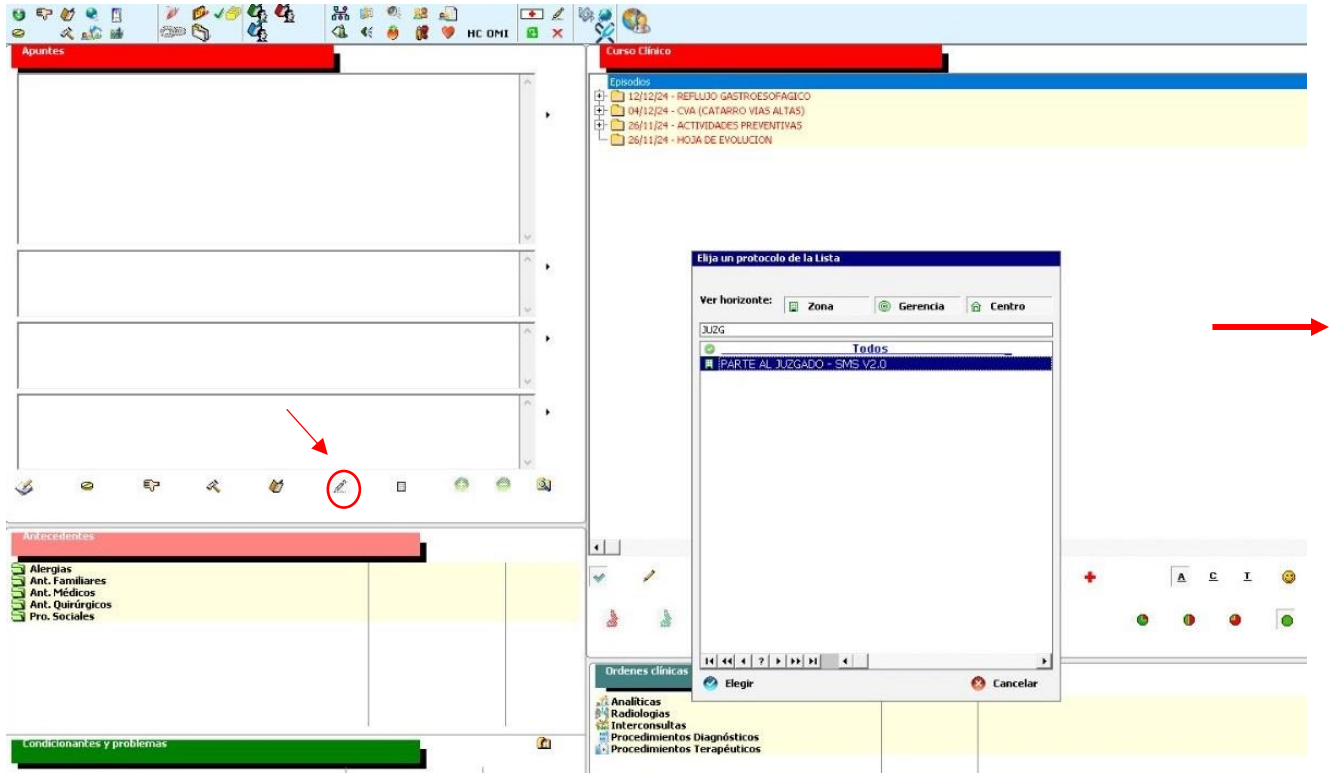
Centro ____ Servicio/Consulta ____

Nombre ____ Área Sanitaria ____

Profesional: Médico ☐ Enfermera ☐ Trabajador Social ☐ Matrona ☐ Psicólogo ☐ Nº Colegiado ____

***En ´´Protocolos´´**

PARTE AL JUZGADO EN OMI (Parte de Lesiones)



***En ´´Protocolos´´**

7.3. ¿Qué puedo hacer como ciudadano?

Como ciudadanos tenemos el deber de notificar.

- Si la situación es **urgente**: **FFCCS** o Tlf de emergencias **112**.
- Si **no** es **urgente**:

– Servicios Sociales Municipales.

– Teléfono de la A.I.E. 968 27 32 09

– Teléfono de **atención al maltrato 116111**

– **Sede electrónica** a través del procedimiento CARM 3621 "Comunicación de situaciones de desprotección de menores". *Puede ser anónimo.

– FUNDACIÓN ANAR

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3621&IDTIPO=240&RASTRO=c$m40288

SedeElectronica

Lunes, 20 de enero de 2025, 20:49h.

Región de Murcia

Unión Europea

REALIZAR UN TRÁMITE | CARPETA CIUDADANA | INFORMACIÓN GENERAL | ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA | CARPETA EMPRESARIAL

Inicio > Realizar un trámite

Comunicación de situaciones de desprotección de menores (código 3621) (SIA 2982965)

INICIAR TRÁMITES

- Solicitar Electrónicamente
- Solicitar Presencialmente

8. Seguimiento en AP.

Pediatra + Trabajador social

- Satisfacer las **necesidades básicas**, deseos y preocupaciones del NNA y subsanar las **carencias** de estimulación, afectivas, educativas o nutricionales, facilitando a las personas responsables recursos y capacitación, cuidados y pautas psicoeducativas.
- Valoración y tratamiento de las **consecuencias psicológicas** del maltrato, tanto en el momento de la evaluación como en el seguimiento.
- **Derivación a Salud Mental infanto-juvenil.**
- Facilitar el **acceso a recursos** especializados para la recuperación del proyecto vital y la inclusión social: programas de refuerzo pedagógico, acceso al empleo juvenil, etc.

9. Recursos

Proyecto Luz

Servicio de Información, Asesoramiento, Prevención, Valoración Psicológica y Tratamiento de Menores Víctimas y Menores Ofensores de Abuso Sexual Infantil (ASI) en la Región de Murcia.

- De enero a junio de 2024 atendió a **226 menores** por abusos sexuales (127 nuevos casos).
- ¿A quién va dirigido?

- Menores con sospechas o indicadores de haber sido víctima de abuso sexual infantil (intrafamiliar 0 extrafamiliar).
- Menores de 14 años de la Región de Murcia que puedan haber agredido o abusado sexualmente de otros menores, que requieran evaluación y/o tratamiento.
- Familiares de los menores citados anteriormente.

- Datos de contacto:

Responsable Proyecto Luz CARM

Tlf. 968 27 31 74

E-mail: **proyectoluz@carm.es**

Asociación Albores - Tlf. 968 90 90 84

Asesoría de Información y Estudios - Tlf. 968273209

Proyecto PEDIMET

Proyecto de evaluación, diagnóstico e intervención psicológica en menores maltratados tutelados.

- ¿A quién va dirigido?

Niños/as y jóvenes de edades comprendidas entre **4 y 17 años** que se encuentran tutelados por la Administración y que presentan reacciones postraumáticas graves derivadas de la exposición a violencia familiar.

- En colaboración con la Universidad de Murcia.
- Ofrece atención y terapia especializada para responder a los problemas de desarrollo, emocionales y de comportamiento que presentan **al año alrededor de 50 menores**.

9.1. Recursos de apoyo a la víctima

ENTIDADES INTERNACIONALES/NACIONALES:

- CRUZ ROJA: https://www2.cruzroja.es
- EDUCO: https://www.educo.org
- ENTRECULTURAS: https://www.entreculturas.org/es/home
- FAPMI-ECPAT: https://www.fapmi.es
- PLATAFORMA DE INFANCIA: https://plataformadeinfancia.org
- SAVE THE CHILDREN: https://www.savethechildren.es

http://www.infocoponline.es/pdf/guiasavethechildren.pdf

- UNICEF: https://www.unicef.es

9.1. Recursos de apoyo a la víctima

ENTIDADES EN LA REGIÓN DE MURCIA:

- Entidades de atención públicas o privadas:

Asociación Murciana de apoyo a la infancia maltratada (AMAIM)

C/San Martín de Porres, 4, 3º A. 30004 Murcia. Tfno.: 968 201 187

- Departamentos Oficiales relacionados con Protección a la Infancia:

• Consejería de política social, mujer e inmigración. Dirección general de familia y menor

– Avda. de La Fama nº 3, 3ª planta. Tfno.: 968 362 035. Fax: 968 365 174

– Información propia en Web Consejería: www.carm.es/ctra/menoryfamilia/

• Protección de menores:

C/ Travesía del Rocío, nº 8 (Edif. Lago). Tfno.: 968 273 160 / 968 273 197

Propuestas de mejora:

I. Establecer **protocolos claros de coordinación** entre el centro de salud, centro educativo, los Servicios Sociales, Hospital y resto de servicios especializados en el ámbito de Maltrato infantil.

II. Protocolo **disponible en** nuestro Sistema de Atención Primaria **OMI**.

III. Responsable de violencia en cada centro.

IV. Hay que **notificar siempre** la situación detectada, aunque se trate de una simple sospecha.

El objetivo principal es la prevención de maltrato infantil mediante la detección precoz.

Bibliografía

1. Ministerio de Sanidad. PROTOCOLO COMÚN DE ACTUACIÓN SANITARIA FRENTE A LA VIOLENCIA EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (2023) [Internet]. 2023. Disponible en: https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/prevencionViolencia/infanciaAdolescencia/docs/Protocolo_comun_sa nitario_violencia_infancia_adolescencia.pdf
2. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Guía para el profesional "Atención al maltrato infantil desde el ámbito sanitario". Consejería de Trabajo y Política Social. Secretaría Sectorial de Acción Social. Dirección General de Familia y Servicios Sectoriales. Disponible en: https://murciasocial.carm.es/documents/20182/25532/Atencion+al+maltrato+infantil+desde+el+ambito+sanitario/9313b82a-8133-40f4-8593-d98625ec6a45
3. Guía sobre la Ley Orgánica de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Septiembre 2021).
4. 29th edition of the Child Maltreatment Report. Child abuse, neglect data released. January 2020. Administration for children & families. USA. Disponible en hhtp://acf.hhs.gov/media/press/2019.
5. Dr. A. Gancedo Baranda, Grupo de Atención al Maltrato Infantil de, la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. Manual para la atención a situaciones de Maltrato Infantil. Grupo 2 Comunicación Médica S.L.; 2021.

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN